13. STRUCTURATION DU SYSTEME VASCULAIRE NOTES

DURÉE : 03:24 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Dans cette vidéo, nous explorons la structuration du système vasculaire durant le développement embryonnaire, en mettant l'accent sur l'interconnexion entre la vésicule vitelline et la cavité amniotique. Les concepts de céphalisation, de cardialisation et de diaphragmatique sont détaillés, illustrant comment le système vasculaire se centralise au fur et à mesure de son développement. En analysant les systèmes cardinaux et la formation de l'axe vasculaire veineux, nous découvrirons comment les mouvements fluidiques et les germinations latérales contribuent à la formation d'une 'aura protectrice', essentielle au développement du système cérébral. Cette approche souligne l'importance de réintégrer la zone B lors du traitement du système nerveux, établissant un lien crucial entre l'ombilic et les structures embryonnaires.

STRUCTURATION DU SYSTÈME VASCULAIRE

Le **système vasculaire**, qui se développe à la périphérie, est profondément intégré à la **vésicule vitelline**. Les **îlots de Wolff-Pander**, par exemple, se forment dans le dédoublement de cette vésicule.

Derrière la vésicule vitelline se trouve la **cavité amniotique**. Imaginez-la comme un **ballon de baudruche** contenant ce système circulatoire qui se retrouve également dans l'axe.

Ce "ballon" va se dégonfler, et l'ensemble du système périphérique va se centraliser. Cette centralisation est orchestrée par la cavité amniotique.

Sa vitesse de croissance différentielle, par rapport au **champ vasculaire primitif** et au développement du **cerveau**, engendre un mouvement d'aspiration. À l'extérieur, cela s'accompagne d'une **poussée transversale**, à la fois thoracique et abdominale.

L'axe longitudinal est plus complexe, intégrant la **céphalisation**, la **cardialisation**, la **diaphragmatisation** et l'ensemble du **péritoine postérieur** jusqu'au **périnée**.

Ce processus est comparable à ce ballon qui s'intègre. Simultanément, à la périphérie, il y a un énorme mouvement qui converge vers le **cordon ombilical**. Le cordon, rappelons-le, est le point de rencontre entre le **pédicule embryonnaire** et la vésicule vitelline, cette dernière se résorbant progressivement.

Le secret, ici, est le **mouvement embryonnaire** et la **motilité du développement** : amener toujours les fluides vers le centre.

Nous étudierons en détail les **systèmes cardinaux** (subcardinal et supracardinal) pour finalement aboutir à un **axe vasculaire veineux**. Ce dernier présente des vestiges spécifiques.

Le système vasculaire veineux se développe de manière **transversale**, et non longitudinale. Il est composé de parties provenant de différentes directions, résultant d'une réunion transversale.

Ceci contraste avec le système vasculaire artériel, qui fonctionne de manière **longitudinale**, avec deux grands conduits. Sur le plan veineux, il s'agit de **germinations latérales**, c'est-à-dire de nouvelles trajectoires.

Lorsque les fluides s'intègrent vers le centre, la **zone B** s'ouvre et se dessine, formant une sorte d'**aura protectrice**. Cette bulle contribue, entre autres, à la construction du **système cérébral**.

La première cavité qui apparaît, ou plutôt la seconde, est la cavité amniotique. C'est à ce moment que le **bouton embryonnaire** devient le futur **épiblaste**, le futur tissu nerveux.

Les deux ne doivent pas être séparés. Si nous voulons traiter le système nerveux, nous devons toujours réintégrer la zone B. Cela converge sur tout l'**axe médian** et finalement au niveau **ombilical**.

L'**ombilic** est le point de rencontre final, la jonction entre le pédicule embryonnaire et la vésicule vitelline.